

Procedimiento de validación local de modelos predictivos

NEXORA Salud · Código PRC-IA-003 · Versión 1.0 · Aprobado por el Comité de IA el 3 de febrero de 2026

1. Contexto

Un modelo que funciona bien en el hospital donde se desarrolló puede fallar en otro. Cambian los pacientes, la forma de registrar los datos y los circuitos asistenciales. La literatura recoge casos de modelos de alerta ampliamente implantados que, al validarse con pacientes de otro centro, detectaron muchos menos casos de los esperados y generaron una gran proporción de falsas alarmas. Este procedimiento existe para detectar esa situación antes de que afecte a los pacientes.

2. Fases

Fase	Qué se hace	Duración orientativa
1. Retrospectiva	Se aplica el modelo a datos históricos de NEXORA Salud y se comparan las predicciones con lo que ocurrió	2-4 semanas
2. Silenciosa	El modelo funciona en tiempo real, pero sus alertas no se muestran a los profesionales	3 meses
3. Piloto supervisado	Alertas visibles en una sola unidad, con revisión de cada alerta	3 meses
4. Despliegue	Activación en el resto de unidades, con seguimiento trimestral	Continuo

3. Umbrales mínimos para pasar de fase

Para modelos de alerta clínica (por ejemplo, sepsis o deterioro):

- **Sensibilidad** (casos reales que el modelo detecta): al menos el 70%.
- **Valor predictivo positivo** (alertas que resultan ser casos reales): al menos el 25%. Por debajo de ese valor, los profesionales tienden a ignorar las alertas.
- **Área bajo la curva ROC**: al menos 0,75 en la población propia.
- Resultados desglosados por **sexo, grupo de edad y centro**. Si algún grupo queda más de 10 puntos por debajo del global, el modelo no avanza de fase.

4. Qué se exige al proveedor

- Descripción de la población con la que se entrenó y validó el modelo.
- Validaciones externas publicadas o, en su defecto, acceso para realizar la fase 1.
- Compromiso de informar de cualquier cambio en el modelo con al menos 30 días de antelación.
- Marcado CE como producto sanitario cuando corresponda.

5. Seguimiento

Tras el despliegue, el Comité de IA revisa cada trimestre la sensibilidad, el valor predictivo positivo y la proporción de alertas descartadas por los profesionales. Una caída de más de 10 puntos en cualquiera

de ellos obliga a volver a la fase 2.